

X 化学放射線療法施行後、デュルバルマブの維持療法を1年行うことが推奨される。

X 肺障害は grade 1 であれば、慎重に経過をみながらデュルバルマブの投与継続が可能である。

X V20 が 40% 以上であれば grade 2 以上の肺障害のリスクが高く、25~30% 以上であれば肺障害自体のリスクが高くなる。

O

O

O 超音波気管支鏡ガイド下針生検 (EBUS-TBNA) での術前の組織学的診断が推奨される。

X 胸壁合併もしくは心膜合併切除が推奨される。

X 肺尖部胸壁浸潤癌に対しては術前化学放射線療法が推奨される。

X EGFR-TKI による術後補助化学療法は、現時点では肺癌ガイドラインで推奨されていない。

X 病変全体径 2 cm 以上の症例では、術後 UFT の内服が推奨されている。

O

O

X 切除可能であれば肺癌に準じた外科的治療が推奨される。

11